جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : شيماء سيد حنفى محمود
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** مصر القديمه **العنوان :** ..
رقم البطاقة : 28609120105566 **رقم التليفون :** 01128904889 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 12-09-1986 **المهنة :** ربه منزل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : أبحاث أورام مسح ذري علي العظام [12966] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: شيماء سيد حنفي محمود
National ID: 28609120105566

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL EGYPT

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي Bone scintigraphy

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





٠١١٢٦٩٠٤٨٨٩
٠١١٤٨٧٨٥٢٢٧

National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

Patient's Name:	**Shaima Said Hanafi Mahmoud**
Date:	**2026-09-07**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

جوستاف روسي

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: -40year-old female with right breast palpable lump from one year

Findings:

right **breast.**

- Fairly dense fibroglandular densities. (ACR b)
- UOQ, middle third irregular high density mass lesion with distortion seen in all area about 5x7cm ,no suspicious calcifications
- **Ultrasound** demonstrated shows irregular hypo echoic solid lesion seen between 11-12 o'clock at middle third, 7 cm from nipple ,reaching the skin causing thickening and dimpling with internal vascularity on color Doppler study measuring 35x26mm.
- Two **level 1 enlarged pathological LNs nodes seen measuring 7x6mm and 12x10mm with focal cortical thickening 6 mm**

left **breast.**

- Faorly dense fibroglandular densities. (ACR cb
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- **Retro areolar dilated ducts**
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion: -

- right ***breast (BIRADS 5): Malignant looking lesion for biopy***
- left ***breast (BIRADS 1): Normal study.***

Best Regards,

DR:Marwa M.Hassan

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]
National ID – Front & Back



[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]
Pathology Report

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL
Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي
جوستاف روسي

Patient Name	شيماء سيد حنفى	**Case No.**	**385562**
Sex/Age	**Female 40 Y**	**Patient No.**	**29049**
Registered Date	**19/9/2026 10:01:43 AM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**27/9/2026 02:33:16 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**30/9/2026 08:45:52 AM**	**Pathology No.**	**2978/26**

Pathology Report

Clinical Data: Right breast mass (BIRADS 5).

Nature of Specimen: Tru-cut biopsy, collected on 16/09/2026.

Gross Examination:
-Four grey, white tissue cores, ranging in size between 0.8 cm & 1.0 cm long, totally submitted.

Technique:
- Sections prepared from paraffin block for immune-staining using Benchmark ULTRA system for;
- ER clone (1E2), PR clone (SP1), Her2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9).

Microscopic examination:
-Histologic type: Invasive duct carcinoma
- Histologic grade: 2 (differentiation 3, pleomorphism 2, mitosis 1)
- DCIS: Absent
- Microcalcification: Present
- Angioinvasion: Absent
- Perineural invasion: Absent
- Tumor infiltrating lymphocytes (TILs): Mild

Results:
* IPT (All controls showed appropriate reactivity):
- ER: Strong nuclear reaction in 95% of tumor cells (score 8/8).
- PR: Strong nuclear reaction in 100% of tumor cells (score 8/8).
- Her2: Faint incomplete membrane reaction in more than 10% of tumor cells (score 1+).
- Ki67%: 20%.

Conclusion:
Right breast mass, Tru-cut biopsy:
-Invasive duct carcinoma, Grade 2.
IPT:
- ER: Positive (score 8/8).
- PR: Positive (score 8/8).

GUSTAVE ROUSSY INTERNATIONAL

Gustave Roussy International-Egypt- Pathology Lab
جوستاف روسي انترناشونال – مصر معمل الباثولوجي

جوستاف روسي

Patient Name	شيماء سيد حنفى	**Case No.**	**385562**
Sex/Age	**Female 40 Y**	**Patient No.**	**29049**
Registered Date	**19/9/2026 10:01:43 AM**	**Referred By Dr.**	**Interventional Radiology**
Validation Date	**27/9/2026 02:33:16 PM**	**Branch**	**Gustave Roussy**
Reporting Date	**30/9/2026 08:45:52 AM**	**Pathology No.**	**2978/26**

- Her2: Negative Low (score 1+).
- Ki67%: 20%.

***Scoring system: "ER, PR"*
ASCO-CAP ER/PR Test Guideline Recommendations: proportion of cells staining (0, no staining; 1, >1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%
and 5, between 67%-100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, week, 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8.
*** Scoring system: "Her2"*
Reference: ASCO-CAP Her2 Test Guideline Recommendation. IHC 0 (Null): as defined by no staining observed. IHC 0+ (Ultra-low) as defined by membrane staining that is incomplete and is faint/barely perceptible and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 1+: as defined by incomplete membrane staining that is faint/barely perceptible and within > 10% of the invasive tumor cells.
IHC 2+: based on circumferential membrane staining that is incomplete and/or weak/moderate and within >10% of
the invasive tumor cells or complete and circumferential membrane staining that is intense and within < 10% of the invasive tumor cells. IHC 3+: based on circumferential membrane staining that is complete, intense > 10% of tumor cells

Signature
Dr. Walaa Ibrahim Ghonaim, MD.

Patient's Name:	**Shaima Said Hanafi Mahmoud**
Date:	**2026-09-07**
Referred by:	Prof.Dr. **no doctor**
Hospital:	**Goustave Roussey International Egypt**

جوستاف روسي

Bilateral Digital soft tissue mammography with high resolution breast sonography revealed:

Clinical summary: -40year-old female with right breast palpable lump from one year

Findings:

right **breast.**

- Fairly dense fibroglandular densities. (ACR b)
- UOQ, middle third irregular high density mass lesion with distortion seen in all area about 5x7cm ,no suspicious calcifications
- **Ultrasound** demonstrated shows irregular hypo echoic solid lesion seen between 11-12 o'clock at middle third, 7 cm from nipple ,reaching the skin causing thickening and dimpling with internal vascularity on color Doppler study measuring 35x26mm.
- Two **level 1 enlarged pathological LNs nodes seen measuring 7x6mm and 12x10mm with focal cortical thickening 6 mm**

left **breast.**

- Faorly dense fibroglandular densities. (ACR cb
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- **Retro areolar dilated ducts**
- Normal skin/nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Conclusion: -

- right ***breast (BIRADS 5): Malignant looking lesion for biopy***
- left ***breast (BIRADS 1): Normal study.***

Best Regards,

DR:Marwa M.Hassan

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]